太原市长期护理保险制度实施细则

第一章　总　则

第一条　为贯彻落实省委、省政府和省有关部门关于建立长期护理保险(以下简称长护险)制度的文件要求,积极应对人口老龄化,着力解决失能人员基本护理保障需求,结合我市实际,制定本实施细则。

第二条　坚持以人民健康为中心,自2027年起建立覆盖全民的长护险制度,为长期失能人员提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理服务保障。立足稳经济、促发展、保就业,引导培育长护险服务市场,协同促进相关领域发展,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

第三条　长护险实行市级统筹,按照省级确定的筹资、待遇基准标准,建立政策统一、基金统收统支、管理服务一体的运行机制。筹资、待遇标准由市医保、市财政部门根据本市经济社会发展水平和基金运行情况报市政府同意后实行动态调整。

第二章　参保与缴费

第四条　本市行政区内市级机关、事业单位、社会团体、企业、个体经济组织、民办非企业单位等用人单位及其职工、退休人员、

灵活就业人员(以下统称就业人员),以及未就业城乡居民(以下统称未就业人员),按属地管理原则参加长护险。

第五条 建立以单位和个人缴费为基础,财政补助、社会捐助、其他资助为补充的多渠道筹资机制。长护险与职工基本医疗保险(以下简称职工医保)、居民基本医疗保险(以下简称居民医保)同步征缴,缴费费率及标准为:

(一)单位职工:由用人单位和个人共同按月缴费,费率为0.3%,用人单位和个人同比例分担,各为0.15%,缴费基数同职工医保。降低职工医保单位费率0.15%,用作长护险单位费率,平移后,职工医保(含生育)单位费率为7.85%。用人单位按规定向税务部门申报缴费。职工个人缴纳的长护险费,按月从职工医保个人账户代扣代缴。

(二)退休人员:由个人缴费,费率为0.15%。原用人单位不缴费。缴费基数为本人上年度12月份基本养老金(当年由在职转退休的人员,缴费基数为当年每月领取的个人基本养老金;无基本养老金的人员,缴费基数为上年度全市职工12月份平均基本养老金)。经本人同意,费款由医保经办机构优先从其职工医保个人账户按月代扣代缴,具备条件也可由发放基本养老金的社保经办机构从其基本养老金代扣代缴或本人通过现金等方式缴纳。

(三)未就业人员:与居民医保费同步缴费,筹资由个人与政府补助按1∶1比例分担,政府补助由中央、地方财政按规定承担。制度建立当年费率减半,从0.15%起步,5年过渡至0.3%(2027年和2028年0.15%、2029年0.2%、2030年0.25%、2031年及以后

0.3%),缴费基数为公布的全省上年度城乡居民人均可支配收入。

(四)灵活就业人员:参加职工医保的,按单位职工费率参保,缴费基数同职工医保缴费基数,不低于全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资的60%,职工医保费率降低0.15%用作长护险缴费,剩余0.15%从其职工医保个人账户代扣代缴;参加居民医保的,按未就业人员政策参保缴费。

(五)18周岁以下人员:18周岁以下未就业人员跟随父母或其他法定抚养人等参保,不单独筹资。孤儿、事实无人抚养儿童等中无法跟从法定抚养人参保的,可由所在地县区民政部门提供人员名单,统一办理参保登记手续;其他无法跟从参保的18周岁以下未就业人员,由其监护人向医保参保地经办机构申请,经审核后按规定办理参保登记。

(六)困难人群:医疗救助基金对符合条件的按未就业人员参保的困难人群个人缴费部分予以分类资助,全额资助特困人员,按个人缴费标准的80%定额资助低保对象和符合条件的防止返贫致贫对象。

第六条 职工医保个人账户可以用于本人及近亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女)参加长护险的个人缴费。鼓励有条件的乡镇(街道)、村(社区)、单位或其他社会经济组织,对未就业人员长护险个人缴费给予资助。

第七条 长护险补缴、退费参照基本医疗保险有关规定执行。就业人员与未就业人员参保关系转换的,缴费规则与基本医疗保

险一致。

第三章　基金管理

第八条　长护险基金统一建账,资金统筹使用,基金纳入社会保障基金财政专户管理,单独建账、单独管理、专款专用,任何单位和个人不得挤占、挪用。

第九条　长护险基金由保费收入、财政补助、利息收入及其他收入构成,按规定支付定点评估机构、护理服务机构的评估服务费、护理服务费及第三方经办服务费。原则上不直接向失能人员发放现金。

第十条　市财政部门将长护险基金纳入财政社保基金专户管理,接收基金收入,根据预算和用款计划及时向支出户拨付基金。市医保经办机构开设长护险基金收入、支出户。收入户用于暂存保费等收入、下拨或上解基金等;支出户用于接收财政专户拨入基金,暂存支出款项、下拨或上解基金、利息收入等。

第十一条　建立基金预算管理制度,科学编制收支预算,强化预算绩效管理和运行监控。严格执行财务制度,规范会计核算和统计分析。健全基金风险防控机制,开展中长期精算分析,实现基金精算平衡。在长护险出现支付困难时,按照规定及时调整筹资或待遇政策。强化财会与审计监督,严守财经纪律,保障基金安全。

第四章　失能评估

第十二条　严格执行国家统一的失能等级评估标准和操作指南，按国家、省有关规定实施失能等级评估，评估结果按规定跨部门互认共享。

第十三条　鼓励发展专业独立的社会化评估机构，建立健全评估人员规范化培训机制，推进评估队伍职业化建设。探索发挥基层医疗机构、家庭医生在失能评估中的作用。

第十四条　参保人员因年老、疾病、伤残等，经医疗机构或康复机构规范诊疗后，失能状态持续6个月（含）以上的，可由本人或其委托代理人向医保经办机构提出评估申请。医保经办机构按国家、省规定组织开展失能等级评估、核查与处置等工作。失能等级评估费由基金和个人按规定分担。

第五章　护理服务

第十五条　长护险服务类型包括居家护理、社区护理、机构护理，符合待遇享受条件的参保人员（以下简称失能人员）或其监护人、委托代理人可根据失能人员自身情况选择一种类型享受待遇。

第十六条　失能人员可根据需求变更护理服务类型，自办理变更手续次月起享受变更后待遇，一个自然年度内变更次数不超过2次。

第十七条　长护险护理服务机构实行定点管理，依法成立的

养老机构、医疗机构或者其他从事养老服务、照护服务或者护理服务的机构，可自愿向医保经办机构申请成为定点护理服务机构。根据定点管理需要，逐步按政府采购规定确定定点护理服务机构。

第十八条 定点护理服务机构应依法与长期护理服务人员签订劳动合同或协议。长期护理服务人员以长期照护师为核心主体，同时涵盖执业（助理）医师、执业护士、康复治疗师（士）、医疗护理员、养老护理员，以及其他经过培训符合条件的人员。

第十九条 申请长期护理服务的人员应遵循自愿原则向其所在的定点护理服务机构提出申请，定点护理服务机构负责受理申请对象的资格审查，审核结果报医保经办机构备案。医保经办机构建立护理服务人员信息库，未入库人员不得从事长护险护理服务。

第二十条 定点护理服务机构在办理失能人员入住手续或提供长期护理服务时，应认真核对失能人员身份，并根据失能评估结论，按规定提供护理服务。

第六章 待遇保障

第二十一条 失能人员自评估结论出具次月起享受待遇。制度起步阶段保障重度失能人员，后期按国家统一安排逐步扩大保障对象范围。

第二十二条 严格执行全省统一的长护险服务项目目录和基金支付范围。领取工伤保险生活护理费的参保人员，不重复享受

长护险相关服务待遇。

第二十三条 失能人员凭社会保障卡、身份证、医保电子凭证、失能评估结论等,与定点护理服务机构签订护理服务合同,并明确相关服务项目、服务内容、服务频次、服务时间等条款。

第二十四条 经失能评估符合长护险待遇享受条件的参保人员,发生的符合规定的护理服务费用,不设起付标准,依据失能等级、选择护理服务方式不同,按照就业人员和未就业人员分别确定支付标准。选择居家护理、社区护理和机构护理的,基金支付比例就业人员分别为75%、70%、65%,未就业人员分别为55%、50%、45%。基金年度最高支付限额就业人员为16920元,未就业人员为12240元,可根据失能等级、服务提供方式分别设置每日(或每月)支付限额。灵活就业人员依据选择的参保类型享受相应待遇。18周岁以下的未就业人员符合待遇享受条件的,按照未就业人员待遇标准享受待遇。

第二十五条 按省级统一政策,建立长护险连续参保、待遇等待期、诚信管理等激励约束机制。做好长护险与各类补贴政策的衔接。

第二十六条 享受长护险待遇的参保人员出现下列情形之一的,终止或中止待遇享受:

(一)参保人员死亡的;

(二)经重新评估不符合待遇享受条件的;

(三)参保人员中止参保或中断缴费的;

（四）因病情需要住院治疗期间；

（五）法律法规和政策规定的其他情形。

第七章　经办服务管理

第二十七条　建立健全经办管理服务体系，市医保经办机构可按规定通过公开招标等竞争性方式有序规范引入第三方机构等社会力量参与长护险经办服务，相关费用依协议约定从基金中支付。

第二十八条　市医保经办机构建立标准化的经办服务流程，统筹全市长护险经办工作，主要职责为：

（一）长护险的参保登记、定点评估机构和定点护理服务机构协议管理、核查考核、费用审核结算以及对第三方机构的考核管理等。

（二）按照统一规划、合理布局、总量控制、鼓励竞争的原则，确定长护险定点评估机构和定点护理服务机构。

（三）与定点评估机构、定点护理服务机构签订定点服务协议，明确权利义务，约定服务范围、服务标准和结算方式等；与第三方机构签订合同，明确服务内容、责任、考核等。

（四）建立健全定点评估机构、定点护理服务机构的申请、考核、退出以及诚信评价、激励约束等机制；对第三方机构、定点评估机构、定点护理服务机构的服务质量、管理水平、费用控制、参保人

员满意度等情况进行日常监督检查和专项监督检查。

(五)与定点评估机构、定点护理服务机构按月结算参保人员发生的符合规定的评估费、护理服务费。

(六)开展宣传、受理举报投诉以及其他经办服务工作。

第二十九条 定点评估机构和定点护理服务机构在中止服务协议期间或终止服务协议之后,向失能参保人员提供服务发生的费用,长护险基金不予支付。应由个人承担的评估费、护理服务费,由参保人员或其家庭支付给定点评估机构、定点护理服务机构。

第三十条 市医保经办机构应规范服务管理行为,加强内部管理,健全内控制度,明确岗位职责,建立风险防控机制。加强协议管理,完善考核评价和激励约束机制,强化对各服务主体的管理。

第三十一条 按照国家统一安排,做好跨统筹地区长护险关系转移接续工作,加快建立健全异地参保、异地享受待遇的规定。

第八章 系统建设与数据共享

第三十二条 应用全国统一的医保信息平台长护险子系统,实现待遇申请、等级评估、护理服务、经办管理、日常监督等一体化管理。推进长护险待遇享受“一人一档”建设。医保、民政、人社、卫生健康、税务等部门加强信息共享。

第九章　基金监管

第三十三条　医保行政部门负责对长护险基金使用进行监督。探索将医疗保障经办、第三方机构、定点评估机构、定点护理服务机构以及评估人员、护理人员、参保人员及其家属等纳入医保信用体系管理，引导守信自律。

第三十四条　健全基金监管体系，建立举报投诉、信息披露、内部控制、欺诈防范等监管长效机制，综合运用日常监管、智能监管、飞行检查、社会监督等多元监管方式，加大基金监管执法力度；加强对护理服务行为、失能等级评估监管，建立完善对相关机构和人员的责任追究机制。

第三十五条　基金使用相关主体出现违法、违规行为的，依法依规进行处理；需其他部门处理或发现涉嫌违法违纪线索的，按程序移交相关部门处理。

第十章　附　则

第三十六条　加强医保、财政、税务、民政、卫生健康、人社、农业农村、残联等部门的协作配合，形成工作合力。医保部门牵头长护险制度建设，制定基本政策，优化管理服务。财政部门负责及时足额安排相关财政补助资金，落实长期护理保险改革相关工作经

费,依职责对长期护理保险基金实施财会监督。税务部门负责做好保费征收等工作。民政、卫生健康、残联与医保部门共同负责加强保险体系和服务体系协同联动、实现失能等级评估结果跨部门互认等,同步做好相关保险与补贴制度的衔接。卫生健康部门负责鼓励基层医疗卫生机构和医养结合机构提供长期护理服务、探索发挥家庭医生在失能等级评估中的作用等。人社部门负责配合做好长护险与工伤保险衔接、退休人员保费代扣代缴等工作。农业农村部门负责做好防止返贫致贫对象认定和帮扶工作。残联协同做好残疾人参保相关工作。

第三十七条 深入宣传长护险制度的重要意义,主动做好政策解读和服务宣传,提高政策知晓率和参保积极性。加强舆论引导,及时回应关切,营造全社会关心支持、共建共享长护险制度的浓厚氛围。

第三十八条 本细则由太原市医疗保障局负责解释,未尽事宜按国家和省有关法律、法规及政策文件执行。

第三十九条 本细则自2026年9月30日起施行,有效期5年。

抄送:市委各部门,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,市检察院,市工、青、妇。
各民主党派太原市委。

太原市人民政府办公室 2026年9月23日印发